

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS EN LA TERAPIA OCUPACIONAL

SEMANA 2

Presente.

- **INDICE:**
- **Desarrollo evolutivo**
- **Objetivo de la terapia ocupacional**
- **Marco de referencia en la terapia ocupacional**

Concepto General

- La Terapia Ocupacional es una disciplina del área de la salud que ayuda a las personas a participar de manera independiente y satisfactoria en sus actividades cotidianas.
- **Busca:**
- Mejorar la calidad de vida.
- Favorecer la independencia.
- Promover la participación social.
- Facilitar el desempeño ocupacional.

Principios Filosóficos

- La Terapia Ocupacional se fundamenta en la idea de que la ocupación es esencial para la salud y el bienestar humano.
- **Principios:**
- El ser humano es activo por naturaleza.
- Las actividades tienen significado y propósito.
- La participación ocupacional favorece la salud.
- Cada persona es única e integral.
- El entorno influye en el desempeño humano.

Tal como enuncia Shannon la Filosofía de la Terapia Ocupacional " representa la visión que tiene la profesión acerca de la naturaleza de su existencia, proporciona sentido y guía las actuaciones de la profesión. También proporciona un conjunto fundamental de valores, creencias, verdades y principios que guían las acciones de los profesionales de este campo"

- Morrison, Olivares y Vidal describen a lo largo de la historia de la terapia ocupacional la existencia de un pre – paradigma y 3 paradigmas : El paradigma de la ocupación, el Paradigma mecanicista y el Paradigma contemporáneo Paradigma social de la ocupación.



Pre-Paradigma Moral

Bases Conceptuales

- Tratamiento Moral XVIII y XIX

Este enfoque se inspiró en la filosofía humanitaria de Iluminismo. Su premisa es que una participación en tareas en la vida diaria podía restituirle a la persona un funcionamiento más saludable y satisfactorio.

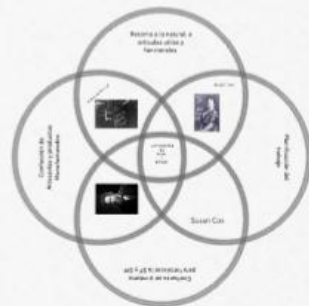
Fue considerado como una terapia ambiental, se modificaban los ambientes físicos, temporales y sociales para corregir los hábitos de vida.

- Movimientos de Artes y Oficios

- Respuesta reaccionaria a la Revolución Industrial y al trabajo mecanizado, impactado en la calidad de vida de la población.
- Se enfoca tanto en la salud mental como en la salud física



Phillip Pinel





Paradigma de la ocupación (1900-1940)

A principio del siglo XX diversos profesionales trabajaron, en las bases principales en lo que sería la terapia ocupacional, se desarrollaron y se escribieron los principios de la profesión. la ocupación se utilizaría para influir en la recuperación de la enfermedad.

Esta tiene un papel esencial en la vida del ser humano e influye en el estado de salud de cada persona, Consiste en la alternancia entre modos de existir, pensar, actuar y requiere un equilibrio entre ellos en el diario vivir.

Adolph Meyer, 1922

Nuestro concepto de hombre es el de un organismo que se mantiene y busca un equilibrio dentro del mundo de lo tangible y lo real a través de la vida activa y del uso activo, esto es, haciendo uso, viviendo y actuando su vida en armonía con su propia naturaleza y la del medio que lo rodea. Es el uso de nosotros mismos lo que deja su impronta final en cada uno de nuestros organismos.

Primera crisis de la terapia ocupacional (1940 -1950)

La terapia ocupacional estuvo bajo la presión de que se estableciera como una práctica más científica, se afirma que la profesión era afectiva pero no tenía teorías que explicaran quien requería de este servicio, el por qué y el cómo de las intervenciones no estaba claro para las personas.

El sistema de salud biomédico .la profesión tomo muy en serio la criticas de los médicos y empezó a cuestionar el paradigma de la ocupación.

La profesión establece una relación con el modelo médico, esto provoca una crisis entre el paradigma ocupacional con el concepto de reduccionismo de la medicina.



PARADIGMA MECANICISTA

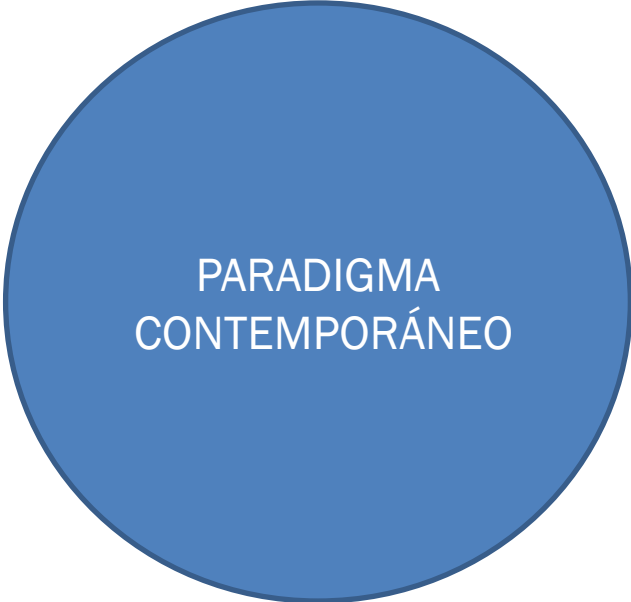
Desarrollado en el siglo XX Es en este paradigma donde la Terapia ocupacional entra en el área de la salud, buscando el reconocimiento de la comunidad medica, como servicio médico, bajo la visión de la biomedicina.

Paradigma en la cual hubo significantes avances tales como: aumento de la tecnología, la comprensión en las estructuras corporales y los procesos que limitan el desempeño y el aumento en la comprensión de la psicodinámica ya que las emociones pueden interferir en el desempeño.

- El denominador común de los 3 enfoques mecanicistas del tratamiento fue un intento de aislar los efectos particulares que se suponía que debía tener cada actividad sobre cada mecanismo.

2da Crisis de la Terapia Ocupacional

- El paradigma mecanicista desvió la disciplina de su misión original y se centró en mecanismos objetivos fuera del ámbito "personas" y "ocupación" como recuperación de la salud.
- El pensamiento holístico fue reemplazado por el reduccionismo.
- La creación de un nuevo paradigma planteaba recuperar elementos del primer paradigma (Escuela del comportamiento ocupacional)



PARADIGMA CONTEMPORÁNEO

- Ciencia de la Ocupación: En búsqueda de un argumento científico para el quehacer de la disciplina.
- Paradigma Post-Positivistas con enfoque Biopsicosociales
- Perspectivas sistémicas Ocupación - Sujeto - Ambiente
- Mary Reilly - La necesidad humana de desempeñarse en juegos y trabajos es el cimiento y la razón de ser de la profesión.
- Sienta las bases conceptuales de la disciplina a través del Comportamiento Ocupacional, como precedente del Modelo de Ocupación Humana.



Paradigma social de la ocupación (2000)



El paradigma social de la terapia ocupacional focaliza la ocupación como un estado de complejidad políticamente ligado a la salud ,justicia y cultura .también busca el enfoque de las comunidades a nivel mundial.

- **.1 Objetivos generales**

- El principal objetivo de la Terapia Ocupacional es capacitar a la persona para alcanzar un equilibrio en las ocupaciones, con el fin de que su vida sea satisfactoria y significativa.
- La intervención en Terapia Ocupacional se dirige tanto a la persona como al entorno, entendiendo el entorno como los distintos ambientes donde se desenvuelve el individuo (entornos de trabajo, domiciliarios, de ocio, comunitarios, urbanísticos, sociales o grupales)

• 2 Objetivos específicos

- 1-. Favorecer la motivación y los intereses de las personas después de la pérdida ocupacional.
- 2-. Favorecer la búsqueda de su identidad psicológica, perdida o fragmentada por distintos acontecimientos o procesos (enfermedad, pobreza, maltratos, marginación...).
- 3-. Ayudar a la persona a elaborar una rutina ocupacional adaptada y significativa que apoye su participación en roles activos y relevantes.
- 4-. Minimizar o eliminar las conductas que interfieran en el desempeño ocupacional.
- 5-. Adquirir, mejorar y potenciar las capacidades y destrezas necesarias para un desempeño ocupacional lo más satisfactorio y funcional posible.
- 6-. Favorecer el desarrollo de habilidades sociales y habilidades emocionales (autoconocimiento, autocontrol, automotivación, empatía) que permitan a la persona asumir un rol activo en la relación con los demás

- 7-. Habilitar en el uso de los productos de apoyo necesarios.
- 8-. Favorecer el acceso al mundo laboral y su mantenimiento.
- 9-. Cubrir las necesidades de disfrute, placer, de exploración, y de participación social, favoreciendo el acceso a los entornos de ocio.
- 10-. Modificación y adaptación de entornos, accesibles y saludables.
- 11-. Eliminación y/o minimización de barreras físicas, psicológicas y sociales.
- 12-. Escuchar, informar y asesorar a la familia del estado general del familiar, de pautas de manejo ante determinadas circunstancias y de los productos de apoyo y de las adaptaciones necesarias, haciéndoles partícipes del proceso de tratamiento.

- **Marcos de Referencias**
- El marco de referencia es una versión de la teoría adaptada y aplicada a la práctica de la terapia ocupacional.
- Es un esquema conceptual que sintetiza e interpreta el conocimiento para que pueda ser utilizado por la disciplina.
- Proporciona un conjunto de suposiciones, postulados y conceptos, así como diferentes abordajes y herramientas prácticas.
- Hay una amplia variedad de marcos de referencia en terapia ocupacional, a continuación se van a describir alguno

- Marcos de Referencias de Terapia Ocupacional son
- ***Marco de Referencia Fisiológico:*** centra su atención sobre los aspectos biológicos de la persona. Está apoyado en una orientación la cual supone que el origen de la enfermedad se debe a alteraciones del equilibrio interno y externo de la persona, causando problemas de sensación, percepción, cognición, movimiento y ejecución de acciones funcionales.
- ***Marco de referencia Conductual.***
- Proporcionar al usuario oportunidades para aprender los comportamientos específicos necesarios para maximizar la independencia funcional dentro del ambiente en el que vive.



- ***Marco de Referencia Biomecánico:*** es uno de los más tradicionales, trata alteraciones físicas, haciendo que su aplicación evite la consolidación de una discapacidad. Este marco puede detectar limitaciones en el rango de movimiento, fuerza muscular, estabilidad y resistencia, siempre y cuando no sea debido a causas neurológicas. Tiene como objetivo el incremento de la movilidad, de la fuerza muscular, de la estabilidad y la resistencia para la mejora de la función. El objetivo biomecánico medible es la flexión de articulación en la zona dañada Su tratamiento se hace mediante movimientos coordinados o aislados, entrenando a la persona que tolere ciertas actividades. Todo esto con el fin de incrementar las diferentes capacidades físicas.
- ***Marco de referencia de Discapacidad Cognitiva.*** Identifica dos fuentes principales de cambio en el nivel cognitivo y el desempeño funcional. Tiene como objetivo facilitar el rendimiento del usuario para cambiar la actividad, mejorar el desempeño
- de rutinas más que intentar cambiar a la persona



- ***Marco de Referencia del Neurodesarrollo:*** este marco dice que todos los patrones de movimiento se originan en el sistema nervioso central, el marco de neurodesarrollo usa estímulos que puedan hacer volver a los patrones normales del movimiento y/o mejorándolos con el fin de hacer desaparecer los patrones causados por alguna patología. Tiene como objetivo restablecimiento de una respuesta adecuada del sistema nervioso central a los estímulos y demandas ambientales, de manera que los patrones de movimiento normales se recuperen progresivamente y desaparezcan los patológicos, mediante la utilización de diferentes técnicas.
- ***Marco de referencia de Integración Sensorial.***
- El objetivo del terapeuta es conseguir una respuesta adaptativa que produzca un comportamiento motor que apoya la interacción con el ambiente. Los parámetros del tratamiento incluyen el control del estímulo sensorial a través de actividades sensoriales que destacan la integración sensorial.



- ***Marco de referencia de Rehabilitación.*** Este marco enseña al usuario a compensar el déficit subyacente que no pueden remediarse. Combinar las adaptaciones con los propios recursos del usuario para que la rehabilitación resulte eficaz. Tener en cuenta la discapacidad del usuario, así como las dificultades que se le presenten a la hora de llevar una vida normalizada para el diseño de un método rehabilitador adecuado y sus adaptaciones.
- ***Marco de referencia Psicodinámico.***
- En éste marco de referencia se usa en salud mental y pretende realizar el cambio llevando el contenido inconsciente productor de síntomas a la consciencia. El objetivo es resolver el conflicto para permitir la satisfacción de actividades de manera aceptable para el ambiente social

- ***Marco de referencia de Adaptación espacio-temporal.***
- La finalidad de éste marco es promover respuestas adaptativas adecuadas al desarrollo dentro del sistema de constitución de estudios de máxima maduración neuronal.
- ***Marco de referencia de Adaptación Ocupacional.***
- El objetivo del marco es influir positivamente en el proceso de adaptación ocupacional interno del usuario, más que la independencia funcional profesional ocupacional debe ser flexible, muy creativo y saber abordar la relación terapéutica desde una perspectiva no tradicional. La aplicabilidad no está definida por el tipo de de dominio práctico, es decir, disfunción física o psicosocial.



Presente.